

Psychotropes et sécheresse de la bouche

 La sécheresse de la bouche ou « xérostomie » est un effet indésirable très fréquent des traitements psychotropes. C'est aussi un des plus négligé, alors que ses conséquences peuvent être très pénibles au quotidien voire avoir des effets graves sur la santé.

 Chez les usagers de psychotropes, la sécheresse buccale est le plus souvent liée à la charge anticholinergique qui entraîne une réduction de la quantité de salive. De très nombreux médicaments sont concernés, le risque augmente avec leur nombre et leurs doses :

- ▶ antipsychotiques : lévoméproméazine, cyamémazine, olanzapine, quétiapine, etc.
- ▶ tous les antiparkinsoniens « correcteurs » : tropatépine, trihexyphenidyl, bipériden
- ▶ antidépresseurs: clomipramine, amitriptyline, paroxétine, etc.
- ▶ anxiolytiques : hydroxyzine

 la clozapine qui a une très forte activité anticholinergique entraîne une hypersialorrhée paradoxale liée à l'absence de déglutition de la salive

 La sécheresse buccale est importante à dépister du fait de son retentissement :

-  sur les gencives et les dents : l'absence de salive augmente le risque de carie, de gingivite, de parodontite, et au final de perte de dents
-  sur l'alimentation: les aliments sont plus difficiles à mâcher et avaler, avec un risque de dénutrition ou de troubles de la déglutition 
-  sur la qualité de vie : inconfort, mauvaise haleine, difficulté à parler longtemps, etc

 Poser la question « avez-vous la bouche sèche » est toujours utile. Il existe des méthodes de « salivométrie » mesurant de manière standardisée la quantité de salive produite par ex avec du matériel absorbant ou après stimulation.

 la sécheresse buccale est difficile à identifier chez les personnes avec des troubles de la communication. Il faut y penser systématiquement.

 D'autres facteurs augmentent la sécheresse buccale

- ▶ personne âgée
- ▶ tabac
- ▶ maladies auto-immunes (syndrome de Gougerot-Sjögren, polyarthrite rhumatoïde, ect.)
- ▶ diabète
- ▶ radiothérapie de la tête et/ou du cou, etc.

 La prise en charge repose sur

-  avant tout, la réduction au maximum de la charge anticholinergique
-  une hygiène bucco-dentaire stricte
-  des consultations dentaires très régulières
-  la stimulation de la salivation par des chewing-gum sans sucre
-  des sprays de salive artificielle
-  un stimulant de la salivation (anétholtrithione), très prescrit mais dont l'efficacité n'est pas clairement démontrée

⚠ ne pas hydrater la bouche avec des boissons sucrées qui augmentent le risque de complications dentaires et gingivales !

👤 Pour les troubles de la déglutition, l'avis d'un.e orthophoniste ou d'un.e ergothérapeute est souvent très utile

Références ↓

<https://doi.org/10.1192/bjo.2023.15>

<https://doi.org/10.1016/j.psychres.2018.03.031>

